

CAPÍTULO 13.6

Manejo del síndrome bronquial obstructivo

PERFIL EUNACOM 1.011.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Score de Tal** es la escala clínica más utilizada en Chile para determinar la severidad de un cuadro de obstrucción bronquial en lactantes. Su correcta aplicación permite categorizar al paciente y decidir la conducta terapéutica (manejo ambulatorio, sala de observación o derivación hospitalaria).

Clasificación de Severidad

El puntaje total se obtiene sumando los puntos de cuatro variables clínicas. El rango va de **0 a 12 puntos**.

TABLA 13.6.1: PUNTAJE TOTAL VS SEVERIDAD DEL SBO

PUNTAJE TOTAL	SEVERIDAD DEL SBO
0 - 5 puntos	Leve
6 - 8 puntos	Moderado
9 - 12 puntos	Severo

Variables del Score de Tal

El score evalúa cuatro parámetros fundamentales: **Frecuencia Respiratoria (FR)**, **Musculatura Accesorio**, **Cianosis** y **Sibilancias**. Cada una recibe de 0 a 3 puntos según el grado de compromiso.

1. Frecuencia Respiratoria (FR)

Es el parámetro más objetivo. Los puntos de corte varían según la edad del lactante, ya que los menores de 6 meses tienen frecuencias fisiológicamente más altas.

TABLA 13.6.2: PUNTOS VS < 6 MESES

PUNTOS	< 6 MESES	≥ 6 MESES
0	< 40	< 30
1	40 - 55	30 - 45
2	56 - 70	46 - 60
3	> 70	> 60

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para FR: Aprende los valores para mayores de 6 meses: empieza en **30** y sube de **15 en 15** (30, 45, 60). Para los menores de 6 meses, simplemente **suma 10** a cada límite (40, 55, 70).

2. Uso de Musculatura Accesorio (Retracción)

Refleja el esfuerzo ventilatorio del paciente. En el SBO, el compromiso progresa desde la base del tórax hacia el cuello.

- **0 puntos:** Sin retracción.
- **1 punto:** Retracción **subcostal** (leve).
- **2 puntos:** Retracción **intercostal** (moderada).
- **3 puntos:** Tiraje **supraclavicular** o cervical (severo).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave con Laringitis: - En el **SBO**, las retracciones van de **abajo hacia arriba** (Subcostal → Intercostal → Supraclavicular). - En la **Laringitis Obstruktiva**, el orden de severidad suele ser inverso o se prioriza el tiraje alto como signo inicial de obstrucción de vía aérea superior.

3. Cianosis

Evalúa la oxigenación clínica. Es un signo tardío de **Insuficiencia Respiratoria**.

- **0 puntos:** Ausente.

- **1 punto:** Cianosis **perioral con el llanto**.
- **2 puntos:** Cianosis **perioral constante** (en reposo).
- **3 puntos:** Cianosis **generalizada**.

4. Sibilancias

Representan el grado de obstrucción del flujo aéreo.

- **0 puntos:** Ausentes.
- **1 punto:** Solo al final de la **expiración** (con fonendoscopio).
- **2 puntos:** En **inspiración y expiración** (con fonendoscopio).
- **3 puntos:** Audibles a **distancia** (sin necesidad de fonendoscopio).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El peligro del Silencio Pulmonar: Si un paciente tiene signos de dificultad respiratoria extrema (taquipnea severa, cianosis, uso de toda la musculatura) pero **no se escuchan sibilancias**, esto se clasifica como **3 puntos** (equivalente a sibilancias audibles a distancia). Esto indica que el flujo de aire es tan pobre que ni siquiera logra generar el sonido de la sibilancia. Es un signo de riesgo vital inminente.

Consideraciones Clínicas

NOTA CLÍNICA

El Score de Tal es dinámico. Se debe evaluar al ingreso y tras las intervenciones (por ejemplo, después de las nebulizaciones o el uso de Salbutamol en puf) para determinar la respuesta al tratamiento.

- **SBO Leve (0-5 pts):** Generalmente manejo ambulatorio con educación a los padres y técnica de inhalación.
- **SBO Moderado (6-8 pts):** Requiere manejo en sala de observación (Servicio de Urgencia) con oxígeno si es necesario y corticoides sistémicos.
- **SBO Severo (9-12 pts):** Requiere hospitalización inmediata y apoyo ventilatorio, ya que el riesgo de agotamiento respiratorio es alto.

Resumen de Puntuación para el Examen

TABLA 13.6.3: VARIABLE VS 0 PTS

VARIABLE	0 PTS	1 PT	2 PTS	3 PTS
FR (≥6m)	< 30	30-45	46-60	> 60
Retracción	No	Subcostal	Intercostal	Supraclavicular
Cianosis	No	Perioral (llanto)	Perioral (reposo)	Generalizada
Sibilancias	No	Espiratorias	Insp/Esp	Audibles distancia / Silencio

Síndrome Bronquial Obstructivo Crisis Asmática Bronquiolitis Aguda

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 10 meses consulta en urgencias por dificultad respiratoria. Al examen presenta taquipnea de 50/min, sibilancias espiratorias, retracción subcostal leve y saturación de 95%. El score de Tal es 6 puntos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo del síndrome bronquial obstructivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SBO leve (0-5 puntos): 2 puffs de salbutamol y alta con signos de alarma
- SBO moderado (6-8 puntos): set de puffs (2 puffs cada 10 min por 1 hora) y reevaluación
- SBO severo (9-12 puntos): agregar oxígeno y considerar hospitalización
- La primera medida en todo cuadro respiratorio agudo es corregir la hipoxemia (saturación <93%)
- Se prefieren los puffs con aerocámara sobre las nebulizaciones
- El ipratropio se usa cuando hay efectos adversos del salbutamol (taquicardia, cardiopatías)
- Corticoides se indican en: no respuesta en 1-2 horas, SBOR, y hospitalización
- Hospitalizar con score 11-12 de inmediato, 9-10 si no mejora en 1 hora, moderado si no mejora en 2 horas
- Solo el oxígeno tiene evidencia sólida en SBO grave; el resto son recomendaciones de guías

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DEL SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO)**PREGUNTA 1**

Lactante de 10 meses consulta en urgencias por dificultad respiratoria. Al examen presenta taquipnea de 50/min, sibilancias espiratorias, retracción subcostal leve y saturación de 95%. El score de Tal es 6 puntos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A)** Administrar 2 puffs de salbutamol y dar alta con signos de alarma
- B)** Realizar set de puffs: 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 1 hora y reevaluar
- C)** Hospitalizar de inmediato e iniciar corticoides sistémicos
- D)** Administrar oxígeno por naricera y nebulizar con adrenalina
- E)** Iniciar antibióticos endovenosos y corticoides

PREGUNTA 2

Lactante de 6 meses con SBO moderado recibe set de puffs de salbutamol durante 2 horas sin mejoría significativa. El score de Tal se mantiene en 7 puntos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Dar alta con salbutamol cada 4 horas en domicilio
- B)** Repetir otro ciclo de set de puffs por 2 horas más
- C)** Hospitalizar e iniciar corticoides
- D)** Cambiar a nebulizaciones con ipratropio exclusivo
- E)** Solicitar radiografía de tórax y hemograma antes de decidir

PREGUNTA 3

Respecto al uso de oxígeno en el SBO, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** Solo se indica cuando el score de Tal es severo (9-12 puntos)
- B)** Se indica cuando la saturación de oxígeno está bajo 93%, independientemente del score
- C)** No tiene evidencia que respalde su uso en el SBO
- D)** Solo se indica si hay cianosis visible al examen físico
- E)** Se indica de rutina en todo SBO como medida profiláctica

RESUMEN: MANEJO DEL SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

El manejo del síndrome bronquial obstructivo depende directamente de la severidad evaluada mediante el score de Tal. En casos leves (0-5 puntos), se administran 2 puffs de salbutamol y se da alta domiciliaria con hoja de signos de alarma que incluyen criterios de severidad y signos de sobreinfección bacteriana como fiebre tardía o deterioro del estado general. En el SBO moderado (6-8 puntos del score de Tal), se realiza un set de puffs consistente en 2 puffs cada 10 minutos durante una hora (5-6 dosis), reevaluando al completar. Las nebulizaciones son equivalentes al set de puffs, pero actualmente se prefieren los puffs con aerocámara por ser más baratos, fáciles y reproducibles en domicilio. El ipratropio puede usarse como alternativa al salbutamol, especialmente cuando hay efectos adversos como taquicardia, en cardíopatas, o cuando el paciente ya viene con mucho salbutamol previo, combinándolo con una dosis más baja de salbutamol. En el SBO severo (9-12 puntos), se debe agregar oxígeno. Sin embargo, la oxigenoterapia se indica ante cualquier saturación bajo 93% independientemente del score, ya que la primera medida en todo cuadro respiratorio agudo es corregir la hipoxemia. Los corticoides se indican en situaciones específicas: cuando no hay respuesta en 1-2 horas, en contexto de SBO recurrente, y siempre que se hospitalice al paciente. Los criterios de hospitalización incluyen: score de Tal de 11-12 puntos (hospitalización inmediata), score severo (9-10) sin respuesta tras una hora de manejo, o score moderado sin respuesta tras dos horas. La evidencia científica solo respalda firmemente el uso de oxígeno en cuadros graves; el resto de medidas son recomendaciones con evidencia limitada pero incluidas en las guías ministeriales.